KronosMedicine

Examen cronometrado: Displasia del desarrollo de la cadera

20 preguntas · 20 minutos
Aprobatorio: 70%

Nombre: Fecha: Calificación:

Instrucciones: lee cada caso y elige una sola respuesta. Anota tus respuestas en la hoja de respuestas. Tienes 20 minutos; empieza cuando te lo indiquen.

1. Durante la exploración de un recién nacido, la cadera derecha se desplaza fuera del acetábulo con una maniobra de provocación, pero en reposo está en su lugar.
¿Cómo se clasifica esta cadera?
A) Luxada
B) Luxable
C) Subluxable
D) Teratológica

2. Recién nacido con mielomeningocele lumbar. Ambas caderas están luxadas, rígidas, y no se reducen con la maniobra de Ortolani.
¿Qué tipo de displasia presenta?
A) Típica
B) Subluxable
C) Transitoria
D) Teratológica

3. En la consulta de un recién nacido se revisan sus factores de riesgo para DDC.
¿Cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo para DDC?
A) Presentación pélvica
B) Sexo femenino
C) Antecedente familiar de DDC
D) Polihidramnios

4. Se analiza la distribución de casos de DDC en un hospital pediátrico.
¿Cuál es la localización más frecuente?
A) Cadera derecha
B) Bilateral
C) Cadera izquierda
D) Es igual en ambos lados

5. Recién nacida de 3 días, producto de primera gesta, obtenida por cesárea por presentación pélvica. Su madre tuvo displasia de cadera.
¿Cuál es su riesgo de DDC?
A) Bajo
B) Intermedio
C) No tiene riesgo si la exploración es normal
D) Alto

6. Médico pasante en un centro de salud que inicia el control del niño sano.
¿Cuándo debe realizarse la primera exploración de caderas?
A) Al mes de vida
B) A los 3 meses
C) En la primera semana de vida
D) Cuando el niño empiece a caminar

7. Recién nacido de 5 días. Con la cadera flexionada a 90°, se abduce suavemente y se empuja el trocánter mayor hacia arriba; se percibe un "clunk".
¿Qué maniobra se realizó y qué indica?
A) Barlow; cadera luxable
B) Galeazzi; acortamiento femoral
C) Pistón; inestabilidad crónica
D) Ortolani; cadera luxada que se reduce

8. En la exploración de un recién nacido sano se escucha un chasquido agudo en la cadera, sin sensación de desplazamiento. Barlow y Ortolani son negativos.
¿Cuál es la conducta?
A) Arnés de Pavlik
B) Ultrasonido urgente
C) Radiografía de pelvis
D) Tranquilizar a los padres y continuar el tamizaje habitual

9. Lactante de 7 meses. La madre nota que un pliegue del muslo es distinto. Barlow y Ortolani son negativos.
¿Qué hallazgo de la exploración es el más útil para sospechar DDC a esta edad?
A) Signo de Ortolani
B) Click de cadera
C) Limitación de la abducción de la cadera
D) Reflejo de Moro asimétrico

10. Lactante de 9 meses acostado boca arriba con caderas y rodillas flexionadas; la rodilla izquierda queda más baja que la derecha.

¿Cómo se llama este signo?

A) Signo de Galeazzi
B) Signo de Trendelenburg
C) Signo de Ortolani
D) Signo de Barlow

11. Niña de 2 años que camina desde los 14 meses. Al apoyarse sobre la pierna derecha, la pelvis cae hacia el lado izquierdo.

¿Qué signo presenta y en qué cadera está el problema?

A) Trendelenburg; cadera izquierda
B) Trendelenburg; cadera derecha
C) Galeazzi; cadera derecha
D) Duchenne; cadera izquierda

12. Lactante de 6 semanas con Ortolani dudoso en la cadera izquierda.

¿Cuál es el estudio de imagen indicado?

A) Radiografía AP de pelvis
B) Ultrasonido de cadera
C) Tomografía
D) Resonancia magnética

13. En una campaña de salud se propone hacer ultrasonido de cadera a todos los recién nacidos sanos y sin factores de riesgo.

¿Qué es lo correcto?

A) No se recomienda como tamizaje universal; se indica ante exploración anormal o factores de riesgo
B) Es lo recomendado para todos
C) Solo se hace a los varones
D) Se sustituye por radiografía al nacer

14. Lactante de 5 meses con limitación de la abducción de la cadera derecha.

¿Qué estudio solicitas?

A) Radiografía AP de pelvis
B) Ultrasonido de cadera
C) Gammagrafía ósea
D) No se requiere estudio

15. En la radiografía de pelvis de un lactante, el núcleo de osificación femoral está por fuera de la línea de Perkins y por arriba de la línea de Hilgenreiner.

¿Qué indica este hallazgo?

A) Cadera normal
B) Cadera luxada
C) Fractura de cadera
D) Sinovitis transitoria

16. Se mide el índice acetabular en la radiografía de un recién nacido.

¿Qué valor se considera normal al nacer?

A) Entre 40° y 50°
B) Más de 45°
C) Menos de 30°
D) Exactamente 60°

17. Lactante de 3 meses con DDC izquierda confirmada por ultrasonido, sin otras malformaciones.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Doble pañal
B) Arnés de Pavlik
C) Reducción cerrada y yeso
D) Reducción abierta

18. Lactante de 2 meses con DDC y artrogriposis múltiple congénita.

¿Por qué no está indicado el arnés de Pavlik?

A) Porque la rigidez articular es contraindicación
B) Porque es mayor de 6 meses
C) Porque la DDC es izquierda
D) Sí está indicado

19. Lactante de 4 meses que usa arnés de Pavlik desde hace 4 semanas; el ultrasonido muestra que la cadera sigue luxada.

¿Qué conducta es la correcta?

A) Suspender el arnés y referir para reducción cerrada
B) Continuar el arnés hasta los 12 meses
C) Cambiar a doble pañal
D) Observación sin tratamiento

20. Niño de 2 años y medio con diagnóstico reciente de luxación de cadera derecha.

¿Cuál es el tratamiento indicado?

A) Arnés de Pavlik
B) Cojín de Frejka
C) Reducción abierta
D) Fisioterapia